

TEMA 7.13 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Trastornos Ansiosos: TAG, Agorafobia y Fobia Social

PERFIL EUNACOM 1.09.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los trastornos de ansiedad constituyen una de las consultas más frecuentes en salud mental. Es fundamental distinguir entre las distintas presentaciones clínicas, ya que, aunque comparten la base de la ansiedad, sus disparadores y manejos terapéuticos tienen matices importantes para el examen EUNACOM.

Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG)

El **Trastorno de Ansiedad Generalizada** se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente que es difícil de controlar. A diferencia del **Trastorno de Pánico**, donde la ansiedad es paroxística y aguda, en el TAG la ansiedad es una "compañera constante".

Clínica del TAG

Expectación Ansiosa: El paciente vive en un estado de alerta permanente, sintiendo que "algo malo va a pasar" en cualquier momento.

Miedo Generalizado: Se describe clásicamente como "miedo a todo y miedo a nada". No hay un objeto fóbico único; el temor puede ser por la salud propia, la seguridad de los hijos, la situación económica o eventos catastróficos improbables.

Síntomas Evitativos: Para intentar calmar la ansiedad, el paciente limita sus salidas o actividades, evitando situaciones que percibe como riesgosas. **Impacto Familiar:** Suele generar conflictos en el grupo familiar debido a la irritabilidad del paciente y sus constantes demandas de seguridad o restricciones impuestas a los demás (ej. "no salgas", "abrigate de más", "llámame cada 5 minutos").

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología y Diferenciación: A diferencia del trastorno de angustia común (pánico), el TAG suele **no presentar crisis de pánico** explosivas. Su ansiedad es de menor intensidad pero mucho más duradera en el tiempo (crónica), lo que limita significativamente la calidad de vida.

Agorafobia

Aunque etimológicamente significa "miedo a los espacios abiertos", la definición clínica moderna es mucho más específica y útil para el diagnóstico.

Clínica de la Agorafobia

El núcleo de la agorafobia es el **miedo a no recibir ayuda** o a no poder escapar a un lugar seguro en caso de presentar síntomas de angustia o vergüenza.

Situaciones Gatillantes: Lugares con muchedumbres (malls, ferias). *Espacios cerrados (ascensores, túneles).* Espacios abiertos desolados (campos, desiertos). *Transporte público (Metro, micro).* **Puentes** (Pregunta clásica de EUNACOM). **Conducta de Seguridad:** El paciente suele estar dispuesto a enfrentar estas situaciones **solo si va acompañado** por alguien de confianza. Esto lo diferencia del TAG, donde el miedo persiste incluso acompañado (miedo a que les pase algo a ambos).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si un paciente cumple criterios de **Trastorno de Pánico** y de **Agorafobia**, el diagnóstico principal según las clasificaciones actuales es **Trastorno de Pánico**, el cual se subdivide en "con agorafobia" o "sin agorafobia".

Fobia Social (Trastorno de Ansiedad Social)

Es un trastorno muy prevalente que suele ser subdiagnosticado. Su característica principal es el temor a situaciones sociales donde la persona pueda ser examinada por otros.

Clínica de la Fobia Social

Miedo al Escrutinio: El paciente teme actuar de una manera que sea humillante o ridícula. **Disparadores Comunes:** Hablar o exponer en público (colegio, universidad, trabajo). *Rendir exámenes orales.* Comer o beber frente a otros. * **Funcionalidad:** A diferencia de otros trastornos, estos pacientes suelen tener una vida social normal, pareja y amigos íntimos, siempre y cuando no se vean expuestos al juicio público.

Diagnóstico Diferencial: Fobia Social vs. Personalidad Evitativa

TABLA 7.13.1: CARACTERÍSTICA VS FOBIA SOCIAL

CARACTERÍSTICA	FOBIA SOCIAL	TRASTORNO DE PERSONALIDAD EVITATIVO
Relaciones interpersonales	Suele tener amigos y pareja.	Muy pocos amigos o ninguno; rara vez pareja.
Foco del miedo	Situaciones de desempeño público.	Sentimiento global de inadecuación y rechazo.
Gravedad	Circunscrita a eventos sociales.	Rasgo de personalidad omnipresente y crónico.

Manejo Terapéutico

El tratamiento de estos trastornos de ansiedad sigue un esquema similar, dividiéndose en manejo de mantención y manejo sintomático.

- **Tratamiento de Mantención (Elección):** Los **Inhibidores Selectivos de la Recaptura de Serotonina (ISRS)** son la primera línea. Buscan estabilizar la ansiedad a largo plazo.
- **Tratamiento Sintomático:** Las **Benzodiacepinas** se utilizan para el control de síntomas agudos o al inicio del tratamiento con ISRS mientras estos alcanzan su efecto terapéutico (2-4 semanas).
- **Psicoterapia:** Fundamental, especialmente en la Fobia Social. La **Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)** con exposición progresiva es la técnica con mayor evidencia.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En el tratamiento de la Fobia Social, el uso de fármacos se reserva para casos graves que afecten significativamente el desempeño académico o laboral. La primera línea siempre debe considerar la psicoterapia.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Ante un caso clínico de un paciente que no puede cruzar puentes o que evita el metro por miedo a quedar atrapado y que nadie lo auxilie, marca **Agorafobia**. Si el paciente está constantemente preocupado por la salud de sus hijos sin motivo real, piensa en **TAG**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Mujer de 55 años refiere que desde hace 2 años vive con la constante preocupación de que algo malo le va a pasar a ella, a sus hijos y a sus nietos. Evita que sus hijos salgan solos, no les permite viajar y la familia se ha vuelto muy limitada. No ha tenido crisis de pánico. ¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos Ansiosos: TAG, Agorafobia y Fobia Social. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El TAG es ansiedad difusa y constante sobre múltiples situaciones; habitualmente sin crisis de pánico discretas.
- La agorafobia es miedo a no recibir ayuda (no solo a espacios abiertos); la persona puede salir si va acompañada.
- Si coexisten trastorno de angustia (pánico) y agorafobia, prima el diagnóstico de trastorno de angustia con agorafobia.
- La fobia específica se trata con psicoterapia de exposición progresiva (desensibilización sistemática); no requiere fármacos habitualmente.
- La fobia a la sangre produce síncope vasovagal (no crisis de pánico), a diferencia de otras fobias.
- La fobia social tiene vida social activa preservada fuera de situaciones de exposición pública; el TPE evita relaciones sociales en general.
- Los exámenes en trastorno de pánico: TSH (hipertiroidismo), ECG (arritmia paroxística), glicemia (hipoglicemia).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS ANSIOSOS: TAG, AGORAFOBIA Y FOBIA SOCIAL)**PREGUNTA 1**

Mujer de 55 años refiere que desde hace 2 años vive con la constante preocupación de que algo malo le va a pasar a ella, a sus hijos y a sus nietos. Evita que sus hijos salgan solos, no les permite viajar y la familia se ha vuelto muy limitada. No ha tenido crisis de pánico. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Trastorno de pánico
- B)** Trastorno de ansiedad generalizada
- C)** Agorafobia
- D)** Trastorno adaptativo ansioso
- E)** Trastorno de personalidad evitativo

PREGUNTA 2

Hombre de 40 años refiere que no puede viajar en metro, no entra a ascensores y evita las grandes tiendas. Cuando lo hace sin su esposa, sufre crisis de angustia. Refiere que lo que teme es "que le pase algo y nadie lo ayude". ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Claustrofobia simple
- B)** Trastorno de ansiedad generalizada
- C)** Agorafobia
- D)** Trastorno de pánico sin agorafobia
- E)** Trastorno obsesivo compulsivo

PREGUNTA 3

Mujer de 22 años refiere que desde pequeña le tienen asco y terror las arañas. Cuando ve una araña sufre una crisis de angustia y tiene que salir corriendo. Su vida es normal en todo lo demás. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A)** ISRS a largo plazo
- B)** Benzodiacepinas crónicas
- C)** Psicoterapia con técnica de exposición progresiva (desensibilización sistemática)
- D)** Haloperidol por síntomas de tipo psicótico
- E)** Hospitalización para manejo del cuadro ansioso severo

RESUMEN: TRASTORNOS ANSIOSOS: TAG, AGORAFOBIA Y FOBIA SOCIAL

El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) se caracteriza por expectación ansiosa constante sobre múltiples eventos o situaciones, con miedo generalizado a que algo malo ocurra, ya sea a la propia persona, a sus seres queridos o en el entorno. A diferencia del trastorno de pánico, el TAG habitualmente no hace crisis de pánico; la ansiedad es más constante y menos intensa. El TAG genera conductas evitativas que limitan la vida cotidiana del paciente y del grupo familiar. El tratamiento combina ISRS con benzodiacepinas sintomáticas y psicoterapia cognitivo-conductual. La agorafobia es el miedo a no recibir ayuda (no simplemente a los espacios abiertos como indica la etimología). Se caracteriza por ansiedad ante situaciones donde la persona se siente desamparada: multitudes, espacios cerrados (ascensores), espacios abiertos, puentes, metro. La diferencia con el TAG es que la agorafobia teme específicamente que algo malo le pase a ella y nadie la ayude, mientras que el TAG teme algo malo para cualquier persona o situación. Si coexiste con trastorno de angustia (pánico), prima este diagnóstico (trastorno de angustia con agorafobia). El tratamiento es el mismo que para el trastorno de angustia. La fobia específica (o simple) es el miedo irracional a un estímulo concreto: animales, sangre, aviones, oscuridad, agujas, espacios cerrados. El tratamiento es psicoterapia con exposición progresiva (desensibilización sistemática). No requiere fármacos habitualmente; en casos graves puede usarse ISRS. El miedo a la sangre típicamente produce síncope vasovagal en vez de crisis de pánico. Se diferencia del TEPT en que en el TEPT hay reexperimentación del evento traumático, ausente en la fobia simple.